

SOAL 4



RESUME RAWAT INAP

Nama Pasien	: S***N***AH	Tgl. Masuk	: 21-05-2025
No. RM	: 00*1*2**	Tgl. Keluar	: 11-06-2025
Tgl. Lahir	: X-X-1967	Lama Dirawat	: 21 hari
No JKN	: *****	Jenis Kelamin	: Perempuan
No SEP	: 0**4R0**0525V0*5*6*	Alergi Obat	: Tidak Ada

Keluhan Utama	demam sejak hari Senin, 19 Mei 2025
Perkembangan Selama Perawatan	Pasien dari IGD dengan keluhan demam sejak hari Senin, 19 Mei 2025 keluhan dirasakan naik turun. keluhan sesak napas dan batuk disangkal pasien. keluhan mual muntah BAB cair tidak ada. RPD Rujuk ke RSCM Post pasang CDL dengan indikasi akses CDL sulit, rencana kontrol poli dr Ignatius namun belum sempat karena pasien demam. CKD on HD S-J, HT, DMT 2 on Insulin. Pasien dilakukan pemeriksaan rekam jantung, lab dan rontgen. Pasien diberikan obat-obatan simptomatik dan antibiotik. Keluhan pasien berkurang. Kondisi pasien stabil. Dari DPJP pasien boleh pulang rawat jalan dan kontrol poliklinik.
Pemeriksaan Fisik	TTV : TD = 173/98. N=134. RR=24. S=37.8. Skala nyeri= 0. EWS=6 . GCS= 456 Kepala : Normal Tidak ditemukan atropi m. temporalis, paresis n VII tidak ditemukan Mata : Normal , Konjungtiva tidak pucat, sclera tidak ikterik, mata tidak, cowong, pupil isokor, diameter 3/3, reflek cahaya langsung +/+, reflek cahaya tidak langsung +/+. Telinga Hidung dan Tenggorokan : Normal Bentuk normal, tidak ada benjolan, tidak ada deformitas, tidak ada cairan keluar Gigi dan Mulut : Normal Gigi lengkap, mulut tidak ada benjolan Leher : Normal tekanan vena juguler tidak meningkat, trakea di tengah, limfadenopati tidak ditemukan, tidak ditemukan massa leher Toraks : Normal Tidak ada benjolan, tidak ada deformitas, tidak ada krepitasi, nyeri tekan negatif Jantung : Normal bunyi jantung I dan II normal, regular, murmur dan gallop tidak ditemukan

	Paru : Kelainan vesikuler +/+ , rhonki rales +/+, wheezing -/- Abdomen : Kelainan supel bU (+) NTE + Kelenjar Getah Bening : Normal Tidak ada benjolan, tidak ada deformitas Genitalia : Bentuk normal Ekstremitas : Bentuk normal, tidak ada deformitas, tidak ada krepitasi, tidak ada nyeri tekan.
Pemeriksaan Penunjang	#ECHOCARDIOGRAPHY : - - Fungsi sistolik LV baik, - (EF Teicholz 35% dan Simpson 68%) - MR trivial- Kontraktilitas RV baik, TAPSE 24 mm - Disfungsi diastolik LV grade II - LVH #THORAX AP / PA: - Radiografi thorax PA/AP Jantung ukuran kesan membesar. Aorta elongasi kalsifikasi. Mediastinum superior tidak melebar. Trakhea relatif di tengah. Kedua hillus suram. Corakan bronkhovaskular kedua paru meningkat dengan kranialisasi dan infiltrat sentral paru. Hemidiafragma dan sinus costofrenikus baik. Tulang-tulang kesan intak. Kateter CDL dengan tip distal di cavoatrial junction. ===== [Conclusion] ===== <u>Kesan: Kardiomegali aorta elongasi kalsifikasi dengan gambaran bendungan paru</u> #GULA DARAH SEWAKTU 10X No # Tanggal Jam Hasil Unit Rujukan Flag 1 2025-05-23 06:00 220 ml < 140 L 2 2025-05-23 11:00 268 ml < 140 L 3 2025-05-25 11:00 191 ml < 140 L 4 2025-05-26 11:00 350 ml < 140 L 5 2025-05-29 06:00 251 ml < 140 L 6 2025-05-30 11:00 398 ml < 140 L 7 2025-05-31 00:00 358 ml < 140 L 8 2025-05-31 06:00 311 ml < 140 L 9 2025-05-31 18:00 201 ml < 140 L 10 2025-06-02 18:00 206 ml < 140 L #GULA DARAH SEWAKTU 10X No # Tanggal Jam Hasil Unit Rujukan Flag 1 2025-06-04 06:00 149 ml < 140 L 2 2025-06-05 06:00 116 ml < 140 L 3 2025-06-10 05:00 145 ml < 140 L 4 2025-06-11 06:00 228 ml < 140 L Procalcitonin : H 212.10 ng/mL Kultur Darah : Jenis Sample : Darah Ditemukan Kuman: 1. Tidak ditemukan pertumbuhan kuman

Diagnosis Utama	Penyakit Jantung Hipertensi dengan Gagal Ginjal on HD
Diagnosis Sekunder	Edema Paru Akut Anemia renal Infeksi post pemasangan CDL DM tipe II Gagal Jantung
Tindakan Utama	Hemodialisa single use
Tindakan Lainnya	Transfusi PRC Injeksi antibiotik Injeksi Insulin Echocardiography X-Ray Thorax EKG Laboratorium darah Kultur Darah
Obat yang diberikan selama perawatan	ISDN 1 mg/mL Candesartan 16 mg B1-B2 multivit TAB Ca Gluco 100 mg/mL, Ranitidine 25 mg/mL Furosemide 10 mg/mL SOL-IPHA (Obat racikan : R/ lasix amp No. 1 S i m m) Sansulin Rapid 100 [IU] Diphenhyd HCl 10 mg/mL, PCT 500 mg Dexamethasone 5 mg/mL Acetylcyst 200 mg Meropenem 1 g POW-HEXP, Amlodipine 10 mg TAB Dextrose 40 % Apidra SS 100 [IU]/mL Ondansetron 4 mg/mL Amitriptyline 25 mg Sucral 500 mg/5 mL ISDN 1 mg/mL Cefepime 1 g Diphenhyd HCl 10 mg/ Meropenem 1 g POW-HEXP Folate 1 mg TAB-MARI NaCl 0,9 % SOL 100 mL Sucral 500 mg/5 mL
Kondisi Saat Keluar Rumah Sakit	Atas Persetujuan Dokter
Instruksi / Tindak Lanjut	Kontrol Poliklinik Rawat Jalan Poliklinik Ginjal tgl: 11-06-2025
Cara Keluar Rumah Sakit	Perbaikan
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)	(TTE) dr. x Sp.PD - KGH